

失智症怎麼診斷？

從「最近常忘記」到找出原因，需要一套完整評估，不是只做一張腦部影像。

失智症不是正常老化。它是認知能力持續下降，並影響原本能獨立完成的日常生活。先確認症狀，再排除可改善的原因，最後判斷是哪一類失智。

1 家屬與病史

何時開始？進展多快？藥物、睡眠、情緒、飲酒、跌倒與疾病史。

2 認知測驗

MMSE、MoCA、CASI；必要時安排完整神經心理測驗。

3 生活功能

記帳、用藥、交通、煮飯、購物，以及洗澡穿衣等能力；可用 CDR 評估。

4 身體與抽血

神經學檢查；依情況驗血，排除代謝、營養、感染等原因。

5 腦部影像

MRI 為主，或 CT；找中風、腫瘤、水腦、出血及腦萎縮型態。

診斷檢查有哪些？

類別	家屬會遇到的檢查
問診	病人＋熟悉日常生活的家屬共同說明；檢視所有處方藥、成藥與保健品。
認知／功能	MMSE、MoCA、CASI、CDR、ADL/IADL；分數需結合年齡、教育程度與日常表現解讀。
抽血	常見包括血球、電解質、肝腎功能、血糖、甲狀腺、維生素 B12／葉酸；其他依病情加驗。
影像	腦部 MRI（或 CT）。若考慮免疫治療，MRI 還要評估微出血與 ARIA 風險。
特殊檢查	神經心理測驗、Amyloid PET、腦脊髓液（CSF）生物標記；僅在有明確臨床問題時安排。

常被忽略、但可能可改善

- 譫妄、感染、脫水或電解質異常
- 憂鬱、睡眠呼吸中止、長期失眠
- 鎮靜安眠藥、抗膽鹼藥等藥物影響
- 甲狀腺異常、維生素 B12 缺乏
- 視力／聽力不佳造成的表現下降

突然變差，不像一般失智進展

若在數小時至數天內突然混亂、嗜睡、發燒、單側無力或說話不清，應立即就醫，先排除譫妄與中風。

重要觀念

一次測驗低分 ≠ 一定失智；MRI 萎縮 ≠ 一定是阿茲海默症。

診斷必須把症狀、進展速度、日常功能、檢查與影像放在一起判斷。

阿茲海默症如何確認？

「臨床上像阿茲海默」與「可接受 Lecanemab」是兩個不同層次。

典型、持續進展

常從新記憶學習困難開始，也可能影響語言、方向感與判斷。

+

排除其他原因

病史、認知與功能評估、抽血、MRI / CT。

+

需要時確認病理

Amyloid PET 或 CSF 證實類澱粉蛋白；免疫治療前是必要步驟。

APOE ε4 基因不是確診工具。它只能協助評估阿茲海默風險與 Lecanemab 的 ARIA 副作用風險；有 ε4 不代表一定會得病，沒有 ε4 也不能排除阿茲海默症。

誰可能考慮 Lecanemab 治療？

- ☐ 診斷為阿茲海默症引起的**輕度認知障礙 (MCI) 或輕度失智**
- ☐ 認知與功能仍在早期範圍；台灣 AUR 參考 MMSE 22-30、CDR 0.5-1
- ☐ Amyloid PET 或合格 CSF 檢測確認**類澱粉蛋白陽性**
- ☐ APOE ε4 為非帶因者或異合子；**台灣適應症不含 ε4 同合子**
- ☐ 治療前 MRI 未見不適合治療的出血／血管／其他重大病灶
- ☐ 病人與照顧者能配合每 2 週輸注、密集 MRI 與急症警覺

最終適用性仍由失智專科醫師依仿單、共病、用藥及 MRI 判定。

先知道的自費門檻

Amyloid PET + APOE ε4 基因檢測

用來確認類澱粉病理並評估 ARIA 風險。

約 7 萬元

健保不給付 | 自費合計估算

提醒：實際收費依醫院、示蹤劑、檢驗方式與是否另含門診／影像判讀而異；治療前 MRI、抽血及其他評估可能另計。請以院方書面報價為準。

阿茲海默症治療不是只有一種

1 | 生活與照護

- 規律運動、睡眠與社交活動
- 控制血壓、血糖、血脂與戒菸
- 矯正聽力／視力、預防跌倒
- 安全、駕駛、財務與照顧規劃

2 | 症狀治療藥物

膽鹼酯酶抑制劑（如 donepezil、rivastigmine、galantamine）與 memantine，可依分期減輕部分認知／功能症狀。

不會清除類澱粉蛋白，也無法治癒疾病。

3 | 疾病修飾治療

Lecanemab 是抗類澱粉蛋白單株抗體，適用於符合條件的早期阿茲海默症。

目標是讓惡化變慢；需權衡療效、ARIA 風險、時間與自費負擔。

作用、能期待什麼、療程怎麼走？

它如何作用？

Lecanemab 是單株抗體，主要辨識腦內的**可溶性類澱粉蛋白原纖維 (Aβ protofibrils)**，也可結合斑塊，協助免疫系統清除類澱粉蛋白沉積。

Aβ 聚集
原纖維／斑塊



抗體結合
標記目標



逐步清除
減少沉積

27.1%

18 個月時，CDR-SB 所測得的認知與功能衰退速度較安慰劑慢

平均差異 0.45 分。這是「群體平均衰退較慢」，不是保證每位病人有效，也不是記憶恢復 27.1%。

它不是治癒，也不會讓已失去的記憶長回來。接受治療後仍可能逐漸退步；可期待的是在部分符合條件的早期病人中，**延後認知與日常功能惡化**。

給藥與安全監測

治療前

確認 Amyloid 陽性、APOE ε4、抽血與一年內基準 MRI；檢視抗凝血／抗血小板藥與共病。

每 2 週一次

10 mg/kg 靜脈輸注，藥物輸注約 1 小時；依院方流程另需報到與觀察時間。

第 5、7、14 次前

安排腦部 MRI（通常於輸注前約一週完成並先判讀）；**前 14 週最需警覺 ARIA**，有症狀時不等例行時間。

持續追蹤

至少每 12 個月評估認知／功能；療程長短由療效、風險、耐受與家庭選擇共同決定。

治療費用（目前自費）

Lecanemab 半年療程：約新台幣 50 萬元

換算一年約 100 萬元。健保署現行藥品資料庫查無 Lecanemab/LEQEMBI/樂意保收載。

約 50 萬元

半年估算 | 健保不給付

可能另計：門診、輸注處置、MRI、抽血、急診與副作用處理。實際藥費依體重、瓶數、院方定價與療程調整而變動；請治療前索取完整書面估價。

時間成本

半年約 13 次輸注，另有門診、MRI 與交通陪同。

不是打半年就完成

目前屬長期治療；若後續 Amyloid PET 的 **Centiloid 降至治療團隊設定的閾值以下**，可討論暫停治療。這不代表自動停藥，目前仍有爭議，須由治療團隊與家庭共同決定。

何時可能暫停／終止？

有症狀或中重度 ARIA、重大腦出血時通常須暫停，約 2-4 個月追蹤 MRI；嚴重副作用或進展至中度失智時，台灣 AUR 建議終止。是否恢復由治療團隊判斷。

Lecanemab 副作用與急診警訊

ARIA 是什麼？

ARIA（類澱粉蛋白相關影像異常）常在 MRI 才被發現，很多人沒有症狀；少數可能嚴重，甚至腦出血或死亡。

ARIA-E：腦水腫或腦溝積液。

ARIA-H：腦內微出血或表層鐵質沉積。

前 14 週最需要警覺，但 ARIA 仍可能在任何時間發生；沒有症狀也不能取代例行 MRI。

第 3 期試驗常見不良反應

輸注相關反應	26.3%
ARIA-H	17.3%
ARIA-E	12.6%
頭痛	11.1%

輸注後也要觀察：反應多發生於首次輸注，可能在點滴中或結束後數小時出現。若有發燒、畏寒、顫抖、全身痠痛、噁心、嘔吐或明顯血壓不適，聯絡治療團隊；若呼吸困難、臉唇腫脹、昏厥或症狀嚴重，立即急診。

出現下列新症狀，立即聯絡治療團隊或就醫

明顯或持續頭痛

意識改變／混亂

暈眩、走路不穩

視力改變

噁心或嘔吐

單側無力／麻木

說話不清

抽搐／癲癇

到急診時，第一句先說：「我正在接受 Lecanemab 治療。」

- 攜帶用藥卡／藥袋，說明最後一次輸注日期，並請急診聯絡原治療團隊。
- 若疑似中風或 ARIA，需以適當腦部影像（常包含 MRI）鑑別。
- 血栓溶解劑與抗凝血治療需格外審慎：**不要自行拒絕或要求用藥，應由急診、中風與失智治療團隊在排除 ARIA 後共同判斷。

哪些情況風險較高？

- APOE ε4 帶因，尤其同合子（台灣適應症不含同合子）
- 治療前已有多發微出血、表層鐵質沉積或疑似大腦類澱粉血管病變
- 正在使用抗凝血藥、需血栓溶解治療，或有重要腦血管病史
- 曾發生 ARIA；風險需依症狀與 MRI 嚴重度重新評估

家屬共同決策 5 問

- 我們理解這是減慢惡化，不是治癒嗎？
- 病人符合早期適應症與 MRI 安全條件嗎？
- 能配合每 2 週輸注與密集 MRI 嗎？
- 能辨認 ARIA 症狀並及時就醫嗎？
- 家庭能長期承擔時間、照顧與自費嗎？

資料來源與使用說明

主要依據：①《Lecanemab 台灣適當用藥建議》2025 年第二版；②《Lecanemab 之急診流程》v3（2025-09-05）；③《Lecanemab 治療共享決策指南》；④ TFDA 樂意保（Lecanemab）審查報告／核准適應症；⑤ 健保署健保用藥品項資料庫（資料更新 115/07/01；查詢日 2026/07/15）。費用依委託者提供之院端估算整理。

本單張供家屬衛教與共享決策，不取代醫師診斷或個別醫療建議。適應症、健保與價格可能變動；請以最新 TFDA 仿單、健保署資料與治療醫院報價為準。